

APPORT DES EXPLORATIONS HORMONALES DANS L'ORIENTATION DU DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE DE LA PUBERTE PRECOCE CHEZ LE GARÇON : A PROPOS D'UN CAS

M. KERROUCHA¹, S. HARITI², Z. OUABBOU¹, M. HERAOUI¹, S. ACHIR², MA. BACHTARZI¹

¹ Laboratoire CENTRAL CHU ISSAAD HASSANI BENI MESSOUS •
² SERVICE ENDOCRINOLOGIE CHU ISSAAD HASSANI BENI MESSOUS

INTRODUCTION

La puberté précoce est définie par l'apparition des signes pubertaires avant l'âge de 8 ans chez la fille et avant 9 ans chez le garçon.

Chez le garçon, la survenue précoce des caractères sexuels secondaires est moins fréquente que chez la fille et revêt une importance particulière sur le plan étiologique. Elle peut résulter d'une activation prématurée de l'axe gonadotrope, correspondant à une puberté précoce centrale, ou d'une production excessive d'androgènes indépendante de cet axe, correspondant à une puberté précoce périphérique.

La puberté précoce centrale chez le garçon doit faire rechercher une cause organique, notamment une atteinte du système nerveux central. L'évaluation clinique, associée aux explorations hormonales, permet de confirmer l'activation de l'axe gonadotrope et d'orienter le diagnostic étiologique. Le dosage des gonadotrophines, notamment de la LH basale, ainsi que celui de la testostérone, constitue ainsi une étape essentielle de cette démarche diagnostique.

OBJECTIF

Mettre en évidence l'apport des explorations hormonales dans l'orientation diagnostique et étiologique d'une puberté précoce chez le garçon.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Il s'agit du cas clinique d'un patient A.M., âgé de 9 ans, originaire du nord de l'Algérie, qui consulte chez un pédiatre libéral suite à l'inquiétude de ses parents à propos d'une accélération staturale associée à des modifications comportementales et d'une hyperactivité. , ce dernier l'oriente vers le service d'Endocrinologie du CHU ISSAAD HASSANI ALGER

La démarche diagnostique a reposé sur une évaluation clinique, biologique, hormonale et neuroradiologique :

- Examen clinique général et recherche de signes d'accélération de la croissance. Évaluation du développement pubertaire selon la classification de Tanner. Appréciation de la croissance staturale et recherche d'une avance staturale.

- Bilan biochimique de routine Un bilan biologique général a été réalisé afin d'évaluer l'état métabolique du patient et de rechercher une anomalie associée. Les explorations biologiques de routine ont été réalisées sur Atellica®.

- Le bilan endocrinien a comporté l'exploration des principaux axes hormonaux, notamment l'axe gonadotrope, avec dosage de la FSH, de la LH basale et de la testostérone, ainsi que l'évaluation des axes thyroïdienne et corticotrope.

Les dosages hormonaux ont été réalisés par électrochimiluminescence sur l'automate Cobas e411®.

- Une IRM cérébrale a été réalisée dans le cadre de la recherche d'une étiologie organique de la puberté précoce

RÉSULTATS

EXPLORATION CLINIQUE

L'examen clinique a objectivé un développement pubertaire avancé, classé Tanner **G4P4A3**, témoignant d'une progression importante de la maturation sexuelle. L'évaluation staturale a montré une avance de la taille estimée à **+2,8 DS**, compatible avec une accélération significative de la croissance.

EXPLORATION BIOLOGIQUE

Le bilan biochimique général était sans anomalie notable. L'exploration des fonctions endocriniennes a montré un axe thyroïdienne et un axe corticotrope conservés, ne retrouvant pas d'argument biologique en faveur d'une atteinte de ces axes.

L'exploration de l'axe gonadotrope a retrouvé une FSH à 1,13 mUI/mL et une **LH basale à 2,42 mUI/mL. La LH basale, nettement détectable et supérieure au seuil pédiatrique rapporté dans ce contexte (> 0,3 mUI/mL)**, associée à un taux détectable de testostérone, était en faveur d'une activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, orientant ainsi vers une puberté précoce centrale.

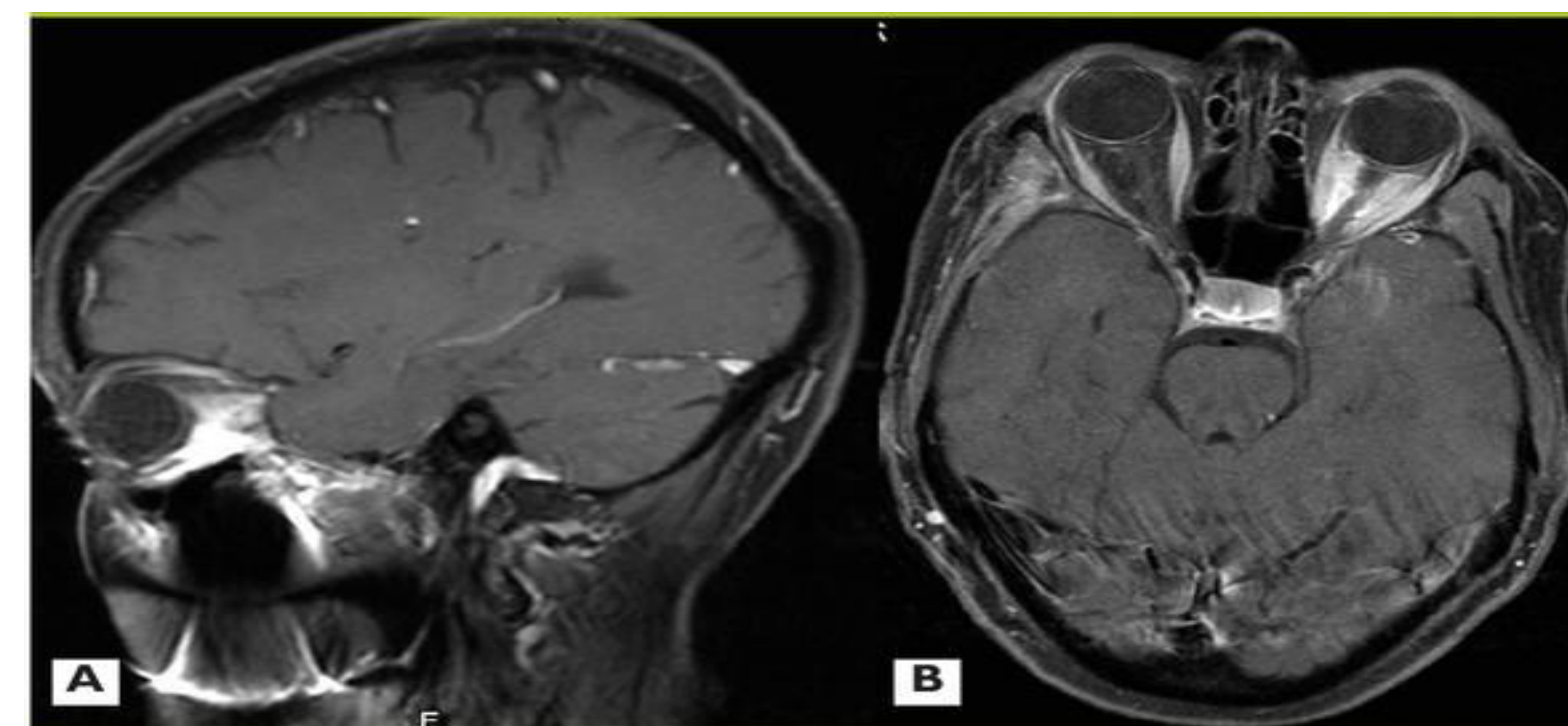
TABEAU 1: résultats de dosage des paramètres hormonales

paramètre	Résultat
FSH	1,13 mUI/mL
LH basale	2,42 mUI/mL
Testostérone	Détectable

EXPLORATION RADIOLOGIQUE

Compte tenu de l'âge du patient et de l'orientation vers une forme centrale chez le garçon, une exploration cérébrale par IRM a été réalisée à la recherche d'une étiologie organique. L'imagerie a initialement évoqué un craniopharyngiome. Après analyse et confrontation des données neuroradiologiques, le diagnostic a finalement été réorienté vers un gliome des voies optiques infiltrant le chiasma optique.

Image 1 : gliome des voies optiques



Ainsi, l'ensemble des données cliniques et hormonales était compatible avec une **puberté précoce centrale d'origine organique**, secondaire à une lésion intracrânienne. Une **chimiothérapie** a été instaurée dans le but de **réduire le volume tumoral et de limiter la progression de la maladie**.

CONCLUSION

Les explorations biologiques et hormonales occupent une place essentielle dans l'orientation étiologique de la puberté précoce chez le garçon.

Dans ce cas, les données hormonales ont orienté vers une origine centrale, secondaire à une lésion organique cérébrale, confirmée par l'imagerie, permettant une prise en charge précoce et adaptée.

RÉFÉRENCES

- Latronico AC, Roberts SA, Alonzo M, et al. Central precocious puberty: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2026;111(8):2101–2144. doi:10.1210/clinem/dgag168.
- Maione L, Bouvattier C, Kaiser UB. Central precocious puberty: Recent advances in understanding the aetiology and in the clinical approach. Clin Endocrinol (Oxf). 2021;95(4):542–555. doi:10.1111/cen.14475.
- Park ES, Park JB, Ra YS. Pediatric Glioma at the Optic Pathway and Thalamus. J Korean Neurosurg Soc. 2018;61(3):352–362. doi:10.3340/jkns.2018.0040.